

Colecistitis y coledocolitiasis

1. Introducción y relevancia clínica

La **colecistitis aguda** es la **inflamación de la vesícula biliar**, habitualmente causada por la **obstrucción del conducto cístico por un cálculo**. Es la complicación más frecuente de la colelitiasis, que afecta aproximadamente al **15–20% de los adultos chilenos**, especialmente mujeres, obesos, y pacientes con dislipidemia o multiparidad.

La **coledocolitiasis**, en tanto, corresponde a la **presencia de cálculos en el colédoco**, pudiendo ser primaria o secundaria (migración desde la vesícula).

Si causa obstrucción biliar, puede complicarse con **colangitis o pancreatitis biliar**, cuadros potencialmente letales si no se diagnostican y manejan a tiempo.

La relevancia clínica radica en que estos cuadros representan una **progresión fisiopatológica común de la enfermedad litiásica biliar**, donde el diagnóstico precoz y el manejo quirúrgico oportuno son claves para evitar complicaciones sépticas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Colecistitis aguda

- En **95% de los casos** hay **obstrucción del conducto cístico** por un cálculo.
- Se acumula bilis estancada → distensión vesicular → **isquemia de la pared** → inflamación química y luego bacteriana (E. coli, Klebsiella, Enterococcus, Bacteroides).
- Si persiste: necrosis, gangrena, perforación o empiema vesicular.

2.2 Colecistitis alitiásica

- 5–10% de casos, sin cálculos.
- Ocurre en pacientes graves (sepsis, trauma, quemaduras, UCI).
- Causa: estasis biliar + isquemia vesicular → mayor mortalidad.

2.3 Coledocolitiasis

- Cálculo en el **colédoco** (comúnmente migrado desde la vesícula).
 - Obstruye el flujo biliar → **colestasis** (ictericia) y **aumento de presión en vía biliar**.
 - Puede complicarse con **colangitis (infección ascendente)** o **pancreatitis biliar**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Colelitiasis no complicada

- Dolor tipo **cólico biliar**:
 - Localización: **hipocondrio derecho o epigastrio**, irradiado a escápula derecha.
 - Inicio postprandial (grasas), duración <6 h.
 - Sin fiebre ni leucocitosis.
 - Laboratorio: normal.
 - Diagnóstico: ecografía → **cálculos vesiculares, sin signos inflamatorios**.
-

3.2 Colecistitis aguda

Clínica clásica (70–80% de los casos):

- Dolor en **hipocondrio derecho o epigastrio**, continuo, >6 horas.
- Fiebre (38–38,5°C), náuseas, vómitos.
- Dolor a la palpación en HCD, **signo de Murphy positivo** (interrupción de inspiración por dolor).
- Puede haber leve ictericia (si compresión del colédoco).

Evolución típica:

- Día 1: dolor y fiebre.

- Día 2–3: leucocitosis, inflamación local.
- Día 3–5: riesgo de necrosis, empiema o perforación.

Formas especiales:

- **Gangrenosa:** ancianos, diabéticos, fiebre alta, sepsis.
- **Empiema vesicular:** pus en vesícula, shock séptico.
- **Enfisema vesicular:** gas en pared (Clostridium).

3.3 Coledocolitiasis

- Dolor tipo biliar + **ictericia fluctuante**.
- Puede acompañarse de **coluria** y **acolia parcial o total**.
- Náuseas, vómitos, fiebre si colangitis.
- Puede presentarse con **pancreatitis biliar** (dolor epigástrico irradiado a dorso, amilasas elevadas).

Signos clásicos:

- **Tríada de Charcot:** fiebre + ictericia + dolor HCD → sugiere **colangitis aguda**.
- **Péntada de Reynolds:** lo anterior + hipotensión + confusión → **colangitis grave/sepsis**.

3.4 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Hepatitis aguda	Ictericia sin dolor intenso, transaminasas >1000 U/L

Pancreatitis aguda Dolor epigástrico en cinturón, amilasas/lipasas ↑↑

Úlcera péptica perforada Dolor súbito, abdomen en tabla, neumoperitoneo

Colangitis Colecistitis + fiebre alta, ictericia y sepsis

Colecistitis alitiásica Paciente crítico, sin cálculos en ecografía

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

Examen	Hallazgo típico	Interpretación
Hemograma	Leucocitosis con desviación izquierda	Inflamación/infección
PCR	Elevada (>8 mg/dL)	Correlaciona con severidad
Bilirrubina total	Normal o leve ↑ en colecistitis / >2 mg/dL en coledocolitiasis	
FA y GGT	Elevadas en obstrucción biliar	
TGO/TGP	Elevadas en coledocolitiasis o hepatitis	
Amilasa/lipasa	Aumentadas si pancreatitis biliar	

Hemocultivos Positivos en 20–30% de coledocolitiasis complicada

4.2 Imágenes

Ecografía abdominal (examen inicial)

- Alta sensibilidad (85–95%) para colecistitis.
- Hallazgos diagnósticos:
 - Litiasis vesicular.
 - Engrosamiento de pared >3 mm.
 - Líquido perivesicular.
 - **Signo de Murphy ecográfico positivo.**
 - Distensión vesicular (>4 cm diámetro transversal).
 - En coledocolitiasis: colédoco >6 mm o visualización de cálculo.

Colangiografía (RMN)

- Diagnóstico de elección para **coledocolitiasis sospechada sin colangitis**.
- Detecta cálculos ≥ 3 mm con alta sensibilidad (95–98%).
- Sin radiación ni contraste yodado.

CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica)

- Diagnóstico y tratamiento (extracción de cálculos, esfinterotomía).
- Indicada solo si **colangitis o alta probabilidad de cálculo confirmado**.

TAC de abdomen

- Menos sensible para cálculos, pero útil ante complicaciones (empiema, perforación, absceso).

4.3 Criterios de diagnóstico de Colecistitis (Guías de Tokio 2018)

A. Signos clínicos locales:

- Dolor HCD o Murphy (+).

B. Signos sistémicos:

- Fiebre, PCR o leucocitosis.

C. Imágenes compatibles:

- Engrosamiento de pared, líquido perivesicular, litiasis impactada.

☐ Diagnóstico “**definitivo**” = A + B + C.

☐ Diagnóstico “**sospechoso**” = A + B.

5. Tratamiento (según guías MINSAL y Tokio 2018)

5.1 Medidas iniciales

1. **Hospitalización.**
2. **Ayuno, hidratación EV** (cristaloides).
3. **Analgesia:** paracetamol + AINE ± opioides.
4. **Antibióticos empíricos:**
 - **Ceftriaxona 2 g EV/día + Metronidazol 500 mg c/8h.**
 - Alternativas: ampicilina/sulbactam o piperacilina/tazobactam.
 - Duración:
 - Colecistitis leve: 3–5 días.
 - Grave o séptica: 7–10 días.

5. Control glicémico y profilaxis tromboembólica.

5.2 Colecistitis aguda

A. Leve a moderada (sin sepsis ni necrosis)

- **Tratamiento de elección:**
 - **Colecistectomía laparoscópica precoz** (dentro de las 72 h del inicio de síntomas).
 - Reduce estadía, complicaciones y costos.
- Si no hay disponibilidad quirúrgica inmediata: antibióticos + cirugía diferida (4–6 semanas).

B. Grave (sepsis, gangrena, perforación)

- Reanimación + antibióticos de amplio espectro.
- **Drenaje percutáneo vesicular** (colecistostomía) en pacientes críticos o no operables.
- Colecistectomía una vez estabilizado.

C. Colecistitis alitiásica

- Igual manejo, pero alto riesgo de sepsis → drenaje precoz preferente.
-

5.3 Coledocolitiasis

A. Manejo general

- Hospitalización, antibióticos, hidratación.
- Control de dolor y fiebre.
- **CPRE terapéutica** (esfinterotomía + extracción de cálculos).

- Posteriormente: **colecistectomía laparoscópica** en el mismo ingreso o en <72 h (previene recidiva).

B. Estrategia quirúrgica combinada

Depende del contexto del centro:

1. **Secuencial:** CPRE → colecistectomía laparoscópica (más usado).
2. **Simultáneo:** CPRE intraoperatoria o exploración de vía biliar (centros especializados).
3. **Inverso:** colecistectomía con exploración biliar, si recursos disponibles.

C. Colangitis aguda (infección biliar)

- Manejo urgente:
 - **Antibióticos de amplio espectro.**
 - **Drenaje biliar urgente (CPRE o drenaje percutáneo).**
- No retrasar drenaje por estudios innecesarios.

5.4 Tratamiento antibiótico sugerido (Tokio 2018)

Severidad	Antibióticos recomendados
Leve (I)	Ceftriaxona + metronidazol
Moderada (II)	Piperacilina/tazobactam o cefepime + metronidazol
Grave (III)	Carbapenémico (imipenem/meropenem) ± vancomicina si sospecha Gram (+) resistentes

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Descripción
Empiema vesicular	10%	Acumulación de pus; fiebre alta, sepsis
Gangrena o perforación	5–10%	Dolor intenso, peritonitis; requiere cirugía urgente
Absceso subhepático	<5%	Dolor, fiebre persistente; manejo con drenaje
Colangitis	10–15% (si coledocolitiasis)	Tríada de Charcot o pentada de Reynolds
Pancreatitis biliar	10–20%	Dolor epigástrico, lipasa ↑, TAC confirma
Recidiva litiásica	10% si no se realiza colecistectomía	
Mortalidad	<1% en leve; 10–20% en grave/sepsis	

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Murphy clínico o ecográfico positivo** → diagnóstico clave de colecistitis.

2. **Colédoco >6 mm + bilirrubina >2 mg/dL** → sospechar coledocolitiasis.
 3. **CPRE solo si alta probabilidad o colangitis**, no como examen diagnóstico de rutina.
 4. **Colecistectomía laparoscópica precoz** es el estándar en colecistitis leve/moderada.
 5. **Antibióticos empíricos** deben cubrir Gram negativos y anaerobios (ceftriaxona + metronidazol).
 6. En **pacientes críticos o sépticos**, preferir **drenaje percutáneo vesicular** antes que cirugía.
 7. **Colangitis con sepsis** = urgencia vital → drenaje inmediato.
 8. Post CPRE, siempre planificar **colecistectomía durante el mismo ingreso** para evitar recidiva.
-



Errores comunes

- Demorar cirugía en colecistitis leve (aumenta riesgo de complicación).
 - Indicar CPRE sin criterios claros (riesgo de pancreatitis post-CPRE).
 - Omitir antibióticos en colecistitis moderada o grave.
 - No sospechar colangitis ante fiebre + ictericia.
 - Confundir hepatitis viral con colestasis obstructiva sin pruebas hepáticas completas.
 - Usar TAC en primera línea sin realizar ecografía (innecesario en mayoría de casos).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Colecistitis aguda** es una inflamación vesicular por obstrucción del cístico, generalmente por cálculos.

2. **Diagnóstico clínico-ecográfico:** dolor HCD + fiebre + leucocitosis + Murphy (+).
3. **Tratamiento:** antibióticos y **colecistectomía laparoscópica precoz** (≤ 72 h).
4. **Coledocolitiasis** se sospecha con ictericia, bilirrubina y FA elevadas → confirmar con colangioresonancia o CPRE.
5. **CPRE terapéutica** para extracción de cálculos + colecistectomía posterior.
6. **Colangitis (Charcot/Reynolds)** = emergencia: antibióticos + drenaje inmediato.
7. **Pronóstico excelente** si diagnóstico y cirugía son oportunos ($<1\%$ mortalidad).